

CAPÍTULO 6.22

Tratamiento de las Dislipidemias

PERFIL EUNACOM 1.04.1.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tratamiento General de las Dislipidemias

Intervenciones Generales (Primera Línea Siempre)

- Modificación dietética y estilo de vida. - LDL alto: Baja ingesta de grasas saturadas (no solo colesterol dietary). - TG altos / HDL bajo: Reducir azúcares refinados. ¡Suspender el alcohol! (Los TG son muy sensibles al alcohol.) - Tratar causas secundarias siempre: el **Hipotiroidismo** eleva proporcionalmente el LDL → tratar el hipotiroidismo primero.

Prioridad de Tratamiento

- **LDL** → Siempre la prioridad #1. Fármaco: **Estatinas**.
- **Triglicéridos** → Se priorizan sobre el LDL solo cuando **TG > 500 mg/dL** (riesgo de Pancreatitis Aguda). Fármaco: **Fibratos**.
- **HDL bajo** → No hay evidencia de manejo directo útil. Mejora indirectamente al tratar el LDL y los TG (y la resistencia a insulina subyacente).

Indicaciones de Estadinas según Riesgo Cardiovascular

TABLA 6.22.1: RIESGO CV (FRAMINGHAM) VS INICIAR ESTATINAS		
RIESGO CV (FRAMINGHAM)	INICIAR ESTATINAS	OBJETIVO LDL
Alto / Muy Alto (> 20% a 10 años)	Siempre (independiente del valor inicial del LDL)	< 70 mg/dL
Moderado (10-20%)	Si, se ofrece (evaluar riesgo-beneficio)	< 100 mg/dL
Bajo (< 10%)	Solo si LDL > 190 de entrada, o > 160 tras 3 meses de dieta fallida	< 130 mg/dL

EUNACOM CRITERIOS

Factores de Riesgo Máximo (obligan a estadinas + objetivo LDL < 70): - IAM previo o Angina estable crónica - Aneurisma aórtico abdominal - Enfermedad arterial periférica o carotídea - **Diabetes Mellitus** (equivalente coronario: riesgo CV similar a haber tenido un infarto)

Fármacos Hipolipemiantes

TABLA 6.22.2: FÁRMACO VS LÍPIDO QUE MÁS REDUCE		
FÁRMACO	LÍPIDO QUE MÁS REDUCE	INDICACIÓN PRINCIPAL
Estatinas (Atorvastatina, Rosuvastatina)	LDL	Primera línea en alto riesgo CV. Reduce mortalidad cardiovascular.
Fibratos (Fenofibrato, Gemfibrozilo)	Triglicéridos	TG > 500 mg/dL (riesgo pancreatitis aguda).
Ezetimibe	LDL	Inhibe absorción intestinal selectiva del colesterol. Se agrega a estatina o la reemplaza ante RAM.
Niacina (Ác. Nicotínico)	HDL (alto)	Sube el HDL, pero sin evidencia de beneficio clínico demostrado.

Nota: Estadinas + Gemfibrozilo está **contraindicado** (riesgo rabdomiólisis). Estadinas + Fenofibrato se puede con precaución.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 56 años con antecedente de IAM hace 6 meses. Perfil lipídico: Colesterol Total 240 mg/dL, HDL 38 mg/dL, Triglicéridos 180 mg/dL, LDL 155 mg/dL. Se plantea terapia hipolipemiante."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Tratamiento de Dislipidemias en Prevención Secundaria (Riesgo Muy Alto): requiere Estadinas de Alta Intensidad (Atorvastatina 40-80 mg o Rosuvastatina 20-40 mg) con meta de LDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50% del LDL basal. Si no logra meta, asociar Ezetimibe 10 mg.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El LDL es el principal objetivo terapéutico en dislipidemias
- Todo paciente diabético es al menos de alto riesgo cardiovascular (meta LDL <70)
- Estadinas de alta intensidad: atorvastatina 40-80 y rosuvastatina 20-40 (reducen LDL >50%)
- Si no se logra meta con estatina: agregar ezetimibe, luego inhibidor de PCSK9
- Triglicéridos >500: fibratos primera línea para prevenir pancreatitis
- No combinar gemfibrozilo con estadinas (riesgo de rabdomiólisis)
- La dislipidemia diabética típica: TG altos, HDL bajo, LDL con partículas pequeñas densas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DE LAS DISLIPIDEMIAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años con DM2 y cardiopatía coronaria conocida. LDL actual 95 mg/dL con atorvastatina 20 mg. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Mantener tratamiento actual
- B) Aumentar atorvastatina a 80 mg
- C) Cambiar a pravastatina 20 mg
- D) Suspender estatina y usar ezetimibe solo
- E) Agregar gemfibrozilo

PREGUNTA 2

Paciente con triglicéridos de 650 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A) Atorvastatina 40 mg
- B) Ezetimibe 10 mg
- C) Fenofibrato 200 mg
- D) Evolocumab subcutáneo
- E) Solo dieta y ejercicio

PREGUNTA 3

¿Cuál combinación de fármacos tiene mayor riesgo de rabdomiolisis?

- A) Atorvastatina + ezetimibe
- B) Rosuvastatina + fenofibrato
- C) Simvastatina + gemfibrozilo
- D) Atorvastatina + omega-3
- E) Pravastatina + ezetimibe

RESUMEN: TRATAMIENTO DE LAS DISLIPIDEMIAS

Las dislipidemias son un factor de riesgo cardiovascular mayor y su tratamiento es esencial en la prevención de eventos ateroscleróticos. El perfil lipídico incluye colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. El LDL es el principal objetivo terapéutico. Las metas de LDL dependen del riesgo cardiovascular: muy alto riesgo (menor a 55 mg/dL), alto riesgo (menor a 70 mg/dL), riesgo moderado (menor a 100 mg/dL), riesgo bajo (menor a 116 mg/dL). Todo paciente diabético se considera al menos de alto riesgo cardiovascular. Las estatinas son el pilar del tratamiento farmacológico. Inhiben la HMG-CoA reductasa, enzima limitante de la síntesis hepática de colesterol. Se clasifican en alta intensidad (atorvastatina 40-80 mg, rosuvastatina 20-40 mg, reducen LDL en más del 50%), moderada intensidad (atorvastatina 10-20 mg, rosuvastatina 5-10 mg, simvastatina 20-40 mg, reducen LDL 30-49%) y baja intensidad (simvastatina 10 mg, pravastatina 10-20 mg, reducen LDL menos del 30%). Si no se logra la meta de LDL con estatinas en dosis máxima tolerada, se agrega ezetimibe (10 mg/día), que inhibe la absorción intestinal de colesterol y reduce el LDL un 15-20% adicional. Si aún no se logra la meta, se agregan inhibidores de PCSK9 (evolocumab, alirocumab) que son anticuerpos monoclonales que reducen el LDL un 50-60% adicional. Para hipertrigliceridemia severa (mayor a 500 mg/dL), los fibratos son primera línea para prevenir pancreatitis.